医院-社区-家庭延续性护理模式对脑卒中失语患者言语康复及生活质量的影响

刘敏，张文静 *
（延安大学咸阳医院，陕西 咸阳，712000）

摘要：目的 探讨医院-社区-家庭延续性护理模式对脑卒中失语患者言语康复及生活质量的影响。方法 选取 2016 年 11 月至 2018 年 9 月我院收治的 160 例脑卒中失语患者为研究对象，按照随机数表法将其分为观察组（常规护理+医院-社区-家庭延续性护理）与对照组（常规护理），各 80 例。比较两组患者的护理效果。结果 护理后，两组患者的言语功能评分、生活质量评分均升高，且观察组高于对照组（$P<0.05$）；观察组患者的完全依从占比、临床护理总有效率高于对照组（$P<0.05$）。结论 医院-社区-家庭延续性护理模式对脑卒中失语患者的护理效果理想。

关键词：医院-社区-家庭延续性护理模式；脑卒中失语；言语康复；生活质量
中图分类号：R473.74 **文献标志码：**A **文章编号：**2096-1413(2019)24-0173-03

Effect of hospital-community-family continuous nursing model on speech rehabilitation and quality of life of apoplectic aphasia patients

LIU Min, ZHANG Wen-jing *
(Xianyang Hospital of Yan'an University, Xianyang 712000, China)

ABSTRACT: ***Objective*** To explore the effect of hospital-community-family continuous nursing model on speech rehabilitation and quality of life of apoplectic aphasia patients. ***Methods*** A total of 160 patients with apoplectic aphasia admitted in our hospital from November 2016 to September 2018 were selected as the research objects. According to the random number table method, the patients were divided into observation group (routine nursing+hospital-community-family continuous nursing) and control group (routine nursing), with 80 cases in each group. The nursing effects of the two groups were compared. ***Results*** After nursing, the language function scores, the quality of life scores of both groups improved, and those in the observation group were significantly higher than the control group ($P<0.05$). The proportion of complete compliance, the total effective rate of clinical nursing in the observation group were higher than those in the control group ($P<0.05$). ***Conclusion*** Hospital-community-family continuous nursing model has ideal clinical nursing effect in apoplectic aphasia patients.

KEYWORDS: hospital-community-family continuous nursing model; apoplectic aphasia; speech rehabilitation; quality of life

脑卒中失语症是由于脑血管出血或缺血性病变伤及大脑语言及其相关区域而造成后天习得的语言功能受损或丧失的一种语言障碍综合征，是脑血管意外后最常见的并发症[1]。由于在院早期康复训练有专业治疗师督促训练，训练效果尚可，但语言功能训练周期长，在院治疗远远不能满足患者语言康复训练的需要，多数患者在短暂的住院治疗后回归社区或家庭进行康复训练。但是由于社区及家庭康复训练条件不健全，人员配备不齐全，患者依从性差，康复效果不佳。加强医院-社区-家庭的延续性护理给患者提供了有利的院外恢复条件，可促进患者言语功能的恢复及生活质量的改善[2]。基于此，本研究选择我院 80 例脑卒中失语患者，给予医院-社区-家庭新型延续护理模式，现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取 2016 年 11 月至 2018 年 9 月我院收治的脑卒中失语患者 160 例为研究对象，按照随机数表法将其分为观察组与对照组，各 80 例。对照组男 42 例，女 38 例；年龄 42~70 岁，平均年龄（54.31±8.19）岁；脑卒中类型：缺血性卒中 45 例，出血性卒中 35 例；失语分型：运动性失语 46 例，感觉性失语 18 例，命名性失语 10 例，其他类型失语 6 例。观察组男 41 例，女 39 例；年龄 41~69 岁，平均年龄（54.87±8.02）岁；脑卒中类型：缺血性卒中 46 例，出血性卒中 34 例；失语分型：运动性失语 44 例，感觉性失语 19 例，命名性失语 12 例，其他类型失语 5 例。两组患者的一般资料比较，差异无统计学意义（$P>0.05$），具有可比性。本研究已经医院伦理委员会批准，所有患者均签署知情同意书。

1.2 纳入及排除标准

纳入标准：符合第四届全国脑血管病会议或《中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2010》[3]中脑卒中的相关诊断标准，并经 CT 或 MRI 诊断为缺血性卒中与出血性卒中；符合中国研究康复中心《汉语标准失语症检查表》（CRRCAE）中脑卒中失语

DOI：10.19347/j.cnki.2096-1413.201924072
作者简介：刘敏（1983- ），女，汉族，陕西彬县人，主管护师，学士。研究方向：神经康复护理。
* 通讯作者：张文静，E-mail:969771106@qq.com.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

相关诊断标准；年龄在 18~70 岁；首次发病，未参加其他康复治疗；意识清醒可以合作；初中文化水平以上；为右利手患者[4]。

排除标准：合并其他重大疾病或病情不稳定的患者；先天性言语障碍的患者；精神疾病患者；母语非普通话者。

1.3 方法

对照组患者出院前进行出院健康指导，发放健康教育手册，指导家属对患者进行言语康复训练。出院后每月进行 1 次电话随访，周期为 3 个月，询问患者一般情况及言语训练情况，并嘱咐其按时复诊。

观察组在对照组的基础上行医院-社区-家庭延续性护理模式。①成立延续性护理小组：由医学康复科医师 1 名、语言治疗师 2 名、护理人员 2 名、社区医护人员 2 名、家庭照顾者 1 名组成延续性护理小组，形成以医院为指导、社区为中心、家庭为单位的三位一体延续性护理小组。②利用医院优厚的医资力量，通过查阅文献、头脑风暴、科室讨论会等措施，针对不同类型的脑卒中失语患者制定相应的康复训练流程。如运动性失语患者有正常的理解能力但表达不到位，难以产生自发性语言，主要对其进行发音器官的训练，从简单的日常对话到小短文阅读，循序渐进地进行说话训练，通过反复多次联系，增强患者表达能力；感觉性失语患者为理解障碍，对其以训练理解力为主，包括听力训练、手势训练、记忆训练及看图片训练；命名性失语表现为言语表达过程中找词困难，缺乏实质词，赘语与空话比较多，康复训练中需加强患者对词汇名称的敏感度，诱导患者主动讲出物品名称，可从日常的“笔、米饭、杯子”等简单用语开始，由简到繁；对于其他类型的失语患者如同小孩，学习讲话一般从构音训练开始，进行循序渐进的语言恢复训练。小组人员将针对性的训练方式通过图文并茂的宣传册方式展现出来，对社区医护人员及患者家属进行详细讲解，并对家属及社区医护人员进行分级培训考核，要求患者家属达到熟悉了解、可按照宣传册指导患者的程度，社区医护人员达到熟练规范、可独立指导患者及其家属的程度，并确保患者在出院后依然可以得到高质量的康复护理指导；由我科室言语治疗师每月末到社区医院对社区医护人员及患者家属进行强化规范康复训练，并对患者在康复训练中存在的问题进行解答。③明确社区医护人员在此次护理模式中的核心地位，由社区医院根据时间自行组织失语患者进行言语康复训练培训，每周最少进行 2 次培训，强化社区医护人员技能；每周组织一次语言康复培训班，将本社区的失语患者进行集中分组训练，并进行小组竞赛，竞赛获胜者分发小礼品（可以是康复训练书籍，由社区医院自行提供），以提高患者积极性；对未参加集体培训的患者进行每周一次家访，上门指导康复训练。④家庭是患者言语康复训练的最小细胞单位，应严格按照出院指导、社区医护人员培训及家访中的康复训练措施进行，配合音乐疗法及亲情关怀，改善患者大脑皮质各兴奋区平衡，提高患者康复训练依从性，促进患者疾病的康复。⑤加强医院-社区-家庭之间的信息交流，由社区护士每月将社区所辖患者康复训练情况与存在的问题上报医院科室，由医院进行评估，并提出解决措施。建立医院-社区-家庭患者微信交流群，便于医-患、患-患交流，要求患者每日进行康复训练后在群里进行“打卡”申明，便于患者之间相互鼓励督促。

注意事项：不论在医院、社区还是家庭康复训练中，治疗者必须充分尊重、理解患者，治疗过程中注意观察患者的行为变化，一旦患者有疲倦迹象应及时调整时间、变换训练项目或缩短训练；在患者心理状态稳定后，鼓励患者多与周围人交流。

1.4 观察指标及效果评价标准

⑴ 比较两组患者护理前、后言语功能。用 CRRCAE 评价语言功能，包括 9 大项 30 分项：听理解（1~6 分）、复述（1~6分）、口头表达（1~10 分）、出声读（1~6 分）、阅读（1~6 分）、抄写（1~6 分）、描写（1~6 分）、听写（1~6 分）和计算（0~20 分）。若患者利手侧偏瘫，则用非利手侧完成，如双手均无法完成，则该项分值记为缺失值。

⑵ 比较两组患者的护理依从性。采用本院自制并经专家认可的患者依从性量表，评价标准：完全依从为患者不需他人督促可自行进行言语康复训练；不完全依从为患者需要在他人督促下完成言语康复训练，或训练时常中断者；完全不依从为在他人督促后亦不能完成言语康复训练。

⑶ 比较两组患者护理前、后的生活质量。采用汉化版脑卒中失语症患者生活质量量表[5]（SAQOL-39g）对患者生活质量进行评价。量表由本人在安静的环境下自主填写，因病情或文化程度等原因无法完成者，可采用访谈法结合自评法进行评价。该量表包括 3 个维度，共 39 个条目，即生理（17 个条目）、沟通（8 个条目）、心理社会（14 个条目），采用 5 级评分制，分值为 0~4 分，得分越高说明生活质量越好。

⑷ 比较两组患者的临床护理效果。评价标准：根据中国康复研究中心的 CRRCAE 进行评价，治愈为总评分较护理前提高 80%以上；显效为总评分较护理前提高>60%~80%；有效为总评分较护理前提高 40%~60%；无效为总评分较护理前提高 40%以下[6]。总有效率=1-无效率。

1.5 统计学方法

采用 SPSS22.0 统计学软件处理数据，计数资料用 n/%表示，用χ^2检验，计量资料用$\bar{x}\pm s$ 表示，用 t 检验，以 $P<0.05$ 为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者护理前、后言语功能比较

护理后，两组患者的言语功能评分均升高，且观察组高于对照组（$P<0.05$，表 1）。

表 1 两组患者护理前、后言语功能比较（n=80，$\bar{x}\pm s$，分）

指标	观察组		t	P	对照组		t	P
	护理前	护理后			护理前	护理后		
听理解	2.24±1.12	4.36±1.08*	12.187	0.000	2.41±1.17	3.51±1.06	6.232	0.000
复述	3.43±1.41	4.91±1.03*	7.581	0.000	3.54±1.34	4.01±1.52	2.075	0.040
口头表达	2.03±1.31	3.98±1.16*	9.968	0.000	2.16±1.51	2.85±1.24	3.159	0.002
出声读	1.87±1.23	3.67±1.56*	8.104	0.000	1.78±1.16	2.65±1.22	4.622	0.000
阅读	2.58±1.34	3.52±1.43*	4.290	0.000	2.27±1.26	2.91±1.37	3.075	0.003
抄写	1.29±1.02	2.89±1.35*	8.458	0.000	1.26±1.11	2.03±1.43	3.805	0.000
描写	0.98±0.65	1.87±0.74*	8.082	0.000	1.01±0.57	1.45±0.81	3.973	0.000
听写	1.78±1.12	2.41±1.24*	3.372	0.001	1.68±1.02	2.04±1.01	2.047	0.044
计算	1.54±1.21	5.68±2.42	13.686	0.000	1.33±1.01	2.65±1.59	6.268	0.000

注：与对照组护理后比较，*$P<0.05$。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.2 两组患者的护理依从性比较

观察组患者的完全依从占比高于对照组，差异具有统计学意义（$P<0.05$，表 2）。

表 2　两组患者的护理依从性比较（n=80，n/%）

组别	完全依从	不完全依从	完全不依从
观察组	67/83.75	11/13.75	2/2.50
对照组	49/61.25	17/21.25	14/17.50
χ^2	12.696	—	—
P	0.000	—	—

2.3 两组患者护理前、后的生活质量比较

护理后，两组患者的生活质量评分均升高，且观察组高于对照组（$P<0.05$，表 3）。

表 3　两组患者护理前、后的生活质量比较（n=80，$\bar{x}\pm s$，分）

组别	时间	生理	沟通	心理社会	总分
观察组	护理前	39.59±6.68	18.36±4.25	40.19±8.02	98.36±7.59
	护理后	57.14±4.86*	27.35±3.61*	50.21±4.51*	134.45±10.28*
t	—	19.002	14.420	9.740	25.261
P	—	0.000	0.000	0.000	0.000
对照组	护理前	40.23±6.24	18.61±4.34	39.08±7.26	96.35±8.48
	护理后	46.38±5.04	21.54±3.59	43.25±4.62	115.67±11.56
t	—	6.858	13.848	4.334	12.053
P	—	0.000	0.000	0.000	0.000

注：与对照组护理后比较，*$P<0.05$。

2.4 两组患者的临床护理效果比较

观察组患者的临床护理总有效率显著高于对照组患者（$P<0.05$，表 4）。

表 4　两组患者的临床护理效果比较（n=80，n/%）

组别	治愈	显效	有效	无效	总有效率
观察组	45/56.25	14/17.50	10/12.50	11/13.75	86.25
对照组	20/25.00	18/22.50	20/25.00	22/27.50	72.50
χ^2	—	—	—	—	5.774
P	—	—	—	—	0.016

3 讨论

《中国卒中流行报告》显示，我国每年有 270 万新发脑卒中患者，且约有 21%~38%的脑卒中患者会发生不同程度的失语[7]。失语后患者大脑语言功能区受损，不能清楚表达自己的生理、心理需求，严重影响患者生活质量。医院的康复治疗可以促进患者语言功能的恢复，但是受我国目前医疗条件限制，脑卒中失语患者的在院康复时间仅为 2 周左右，远远不能满足患者语言康复功能恢复的需求。患者常因出院后护理断档而错失黄金恢复期，其中约有 50%的患者会出现永久性的语言功能缺损。为患者提供连续的、不间断的护理是目前国内外学者对卒中护理的新方向[8]。医院–社区–家庭护理模式的出现充分发挥了社区医院及家庭护理的能动优势，为解决患者出院后护理断档情况提供了有效的解决措施。在医院指导下，社区与家庭联动参与患者护理，在卒中后 12 个月内对患者进行言语康复训练，加速患者自然恢复，为改善患者语言功能、提高生活质量提供了极大的助力[9]。

本研究结果显示，护理后，两组患者的言语功能评分、生活质量评分均升高，且观察组高于对照组（$P<0.05$）；观察组患者的完全依从占比、临床护理总有效率高于对照组（$P<0.05$）。分析其原因为，①医院–社区–家庭延续性护理模式可充分发挥市级医院医资力量雄厚的优势，给社区医院及家庭照顾者提供良好的护理培训，保证了患者在出院后依旧可以得到高质量的康复训练护理服务[10]；②明确社区护理的核心地位，社区医护人员康复训练技能提升后，可根据社区医院就医接诊压力小、时间充裕、距离患者近的特点，每周最少进行 2 次康复培训，并进行分组竞赛、微信打卡等活动提高患者康复积极性与依从性，利于患者语言功能的恢复，生活质量的改善[11]。患者康复训练的直接影响者为家庭照顾者，家庭照顾者经医院康复训练培训后可提升康复训练技能，给予患者更加有效的康复锻炼，配合亲情关怀、音乐疗法，给患者创造有舒缓温馨的恢复环境，利于患者语言功能早日恢复[12]。医院–社区–家庭信息交流的加强，方便医生对患者在康复训练过程中的指导，避免出院康复训练中因训练错误或不到位而延误恢复时机[13]。

综上所述，医院–社区–家庭延续性护理模式可提高患者治疗依从性，临床护理效果好，有利于脑卒中失语患者语言功能的康复及生活质量的提高。

参考文献：

[1] 王甜甜,樊红,敖丽娟,等.重复经颅磁刺激在卒中后失语症中的应用进展[J].中国康复医学杂志,2017,32(1):113–116.
[2] 王慕然,宫悦华,柏亚妹,等.延续护理在脑卒中失语患者言语康复中的应用研究[J].中国康复医学杂志,2018,33(11):1338–1341.
[3] 中华医学会神经病学分会脑血管病学组急性缺血性脑卒中诊治指南撰写组.中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2010[J].中华神经科杂志,2010,2(2):50–59.
[4] 张庆苏,纪树荣,李胜利,等.中国康复研究中心汉语标准失语症检查量表的信度与效度分析[J].中国康复理论与实践,2005,11(9):703–705.
[5] 林润,陈锦秀,冯木兰,等.脑卒中失语症患者生活质量量表汉化及信效度测评[J].中华护理杂志,2013,48(4):349–351.
[6] 马洪卓.心理结合语言康复在脑卒中后语言及心理障碍病人中的应用研究[J].中西医结合心脑血管病杂志,2016,14(11):1279–1281.
[7] 李薇薇,何小俊.脑卒中失语症言语康复训练研究进展[J].护理研究,2018,32(22):3514–3517.
[8] 邱晶,徐志培,汤先萍.我国脑卒中延续性护理研究现状及启示[J].齐鲁护理杂志,2018,24(18):101–103.
[9] 迪晓霞,司海燕,周青,等.脑卒中失语症的康复效果分析[J].临床医学研究与实践,2018,3(22):33–34,37.
[10] 薛杨,赵霞,宁小香.脑卒中后遗症患者一例的家庭护理[J].解放军护理杂志,2014,31(5):56–57.
[11] 张建宏,范建中,漆松涛,等.认知康复在重型颅脑损伤失语症治疗中的作用[J].中国康复理论与实践,2012,18(6):509–512.
[12] 李培珍,吴熹,徐微微.自制语言康复光碟在脑卒中失语患者中的应用[J].护理学杂志,2013,28(9):76–78.
[13] 兰丽梅,彭惠兰,杨秋菊,等.时间护理联合唇舌功能训练在脑卒中运动性失语患者早期康复中的应用[J].广东医学,2012,33(22):3508–3510.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net